原始研究

中文研究题名占位：从完整材料到可追溯的证据表达

Author A, M.D.[1]；Author B, Ph.D.[2]；
Author C, M.D., Ph.D.[1,*]

摘　要

背景

本文件是用于核验版式的原创中性样板，不报告真实研究结果。摘要首先说明研究问题和既有证据，再交代需要解决的具体缺口。实际汉化时，应完整保留原文对于研究对象、既往发现和知识边界的描述；不能以通用背景替换作者原有论证，也不从外部资料添加原稿没有报告的发现。题名、作者和单位均为占位，正式使用前须逐项替换。

方法

本段演示结构化摘要的方法栏目。真实译稿应交代研究设计、研究人群或实验对象、干预与比较、主要结局以及分析范围。原文中的样本量、剂量、时间点、单位、注册信息和统计方法均须忠实保留。本样板没有研究参与者、实验处理或统计检验，不提供可以据此实施的临床或实验方案。补充材料是否提供，应以本次实际收到的文件为准。

结果

本段仅检验中文结果段的字密度、标点和断行，不包含实验数据。正式稿须区分绝对变化和相对变化、组间比较和组内比较、观察到的趋势和经过检验的差异。应保留误差指标、区间端点、正负方向以及所有限制条件。图注和表下注释具有独立的信息范围，不能因正文已引用图表就省略；摘要中的数字也应与正文和对应表格分别核对。

结论

中性样板用于展示刊头红色、浅米色横栏、灰色作者信息、窄摘要区与右侧出版信息的关系。实际论文的结论应与作者的证据强度一致，保留可能性、局限和适用范围。此处不构成医学建议，不是期刊官方模板。仅供学术交流，出版物版权归原作者及出版商所有。

[1] 作者单位一（占位）；[2] 作者单位二（占位）。

* 通信作者地址与电子邮箱待填。

在线日期、DOI 与版本信息按目标原文核实。

本示例无真实作者或研究资料。

引言

本页正文为原创排版示例。研究论文通常先提出问题，说明已有证据能够回答什么，再确定尚待解决的部分。实际翻译应沿用原文的论述顺序，保留范围限定与证据层级。术语、缩写、基因或蛋白名称需要前后一致，文内引文则应链接到原有编号对应的条目[1]。

双栏页面按照左栏、右栏及跨页续句的顺序阅读。图中文字不属于邻近正文，下载来源标记也不应混入句子。若一句话跨页，应先确认首尾衔接，再决定中文分页位置；不能为凑版删除限定条件、压缩成摘要或重复接入同一段。

方法

资料范围与组织

本示例采用中性占位内容，不报告真实样本、干预或结果。真实项目应分别登记题名摘要、正文方法、完整图注、表格、书目、作者声明和原文出处。正文提到某份附录，不意味着该附录已随主文提供；仅有链接时，应在范围说明中明确。

可编辑文字与图像素材分别维护。图内保留英文时，应补充完整中文标签释义。复用原图前需要逐幅确定真实边界，保留全部面板、坐标轴和注释，并移除个人下载来源对象。仅修改裁剪框或覆盖白块不能证明隐藏标记已被删除[2]。

阅读与数据核验

数值核验关注单位、方向、范围和比较对象。表格中的百分比、总数与分组数应对应源文；原文已有疑点时，不得根据常识静默统一。排版调整完成后，应再次核对正文和书目的内容指纹，确认没有漏段、重复或字形丢失。

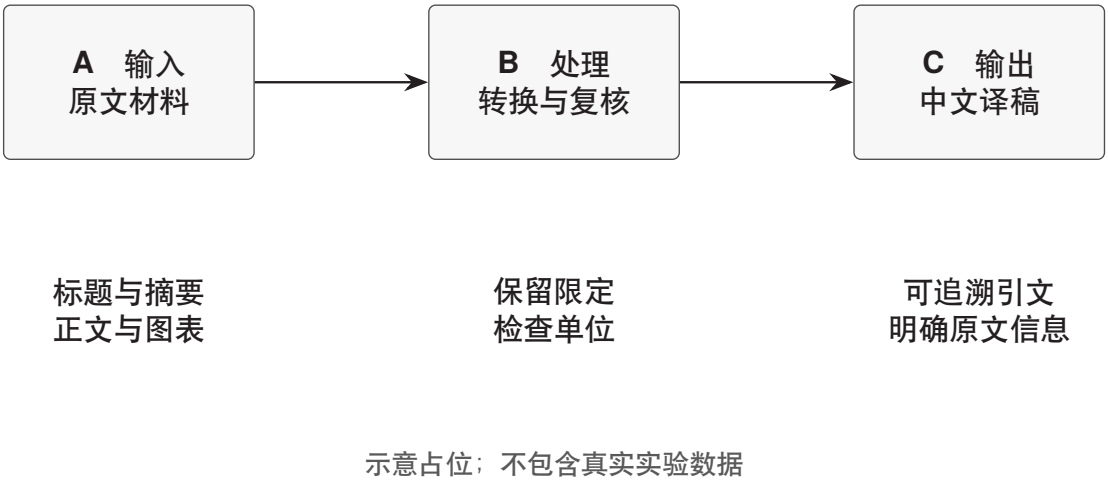


图 1. 中性证据链示意（占位图，无实验数据）。 **A**，输入节点表示需要核对的原文材料。**B**，处理节点表示逐段转换及复核。**C**，输出节点表示正文、图注和书目等独立交付部分。箭头仅表示本示例的阅读顺序，不代表因果关系、效应方向或数量变化。该图由模板自行绘制，所有节点均为文字占位；无样本量、误差线、统计检验或比例尺。实际论文图注应逐项保留原稿报告的样本量、单位、检验方法、限定及图形署名。

图文安排

本页将一幅原创矢量占位图置于正文附近，完整图注采用浅米色底、无衬线小字号。实际译稿应根据图形尺寸和图注长度分配空间，避免把所有大图集中在文末。大图需要独立页时，应在正文中保持清楚的引用和顺序。

表 1. **中性内容覆盖表（占位，无研究数据）。**

内容类别	核验对象	完成条件
正文	各节与跨页续句	保留完整顺序与限定
图表	全部分面、注释与单位	真实边界及可读性通过核验
书目	原编号与原始条目	引文能够跳转至对应条目
来源	原题、版本与出版信息	缺失字段明确，不编造

注：本表用于排版演示，所有条目均为原创占位，不表示实证结果。

结果

本段只展示表格后的正文衔接。真实结果应按照研究问题和测量对象组织，明确某个结论来自图中的哪一面板或表格的哪一行。对于不同实验层级、不同随访时点或不同分析人群的发现，应保持原文区分，不能合并为范围更广的结论。

表格具有自己的标题、变量名称与脚注。中文重排可以改变行高和列宽，以便在保留内容的前提下提高可读性；不能通过省略行列、缩短范围或改变单位来适应页面。图注中的误差线、统计检验及样本定义同样需要逐项核对。

讨论

这一版式样板根据一次核验的研究论文外观提炼，不能代表该期刊所有年代、文章类型或出版版本。实际项目仍应量测题名区、栏目结构、配色与正文密度。中文字符宽度和译文长度会改变分页，所以应保留结构关系，并对所有输出页逐页检查。

正文、图、表与完整图注尽量交替呈现。减少空白时，应先调整段落流动和图表位置，再检查图注行距与小字号是否仍易读。不能用删去科学内容、裁掉面板或把原刊页码当作中文分页来解决空间问题。

局限与适用范围

本示例没有真实研究资料，不提供疾病风险、疗效、安全性或因果结论。正式译稿必须保留作者明确写出的不确定性，并将未提供的补充文件与已经译出的主文清楚区分。

作者信息与声明

[1] 作者单位一（占位）；[2] 作者单位二（占位）。通信、资助、利益冲突和数据共享信息均须按原文替换。本中性文件仅供学术交流；出版物版权归原作者及出版商所有。

参考文献（示例占位）

1. Author A. (20XX). Example reference title. *Journal placeholder*. 卷、页码与 DOI 待填。此条仅供演示引文跳转。

2. Author B. (20YY). Another example reference title. *Journal placeholder*. 出版信息待填；不要把占位条目带入正式译稿。

原文信息

以下字段全部为示例占位：作者；英文原标题；期刊；年份；卷期；页码或文章号；DOI 或来源链接。实际使用时必须逐项替换并核对。

本文件是 The New England Journal of Medicine 风格的非官方中文译稿样板，依据一次已核验文章版式进行结构化改编，不代表该期刊所有年代或文体的统一标准，也不保证像素级复刻。无真实论文内容或期刊标识图像。